

B 43- Carence en Vitamine D chez les Patients Atteints de Thyroïdite d'Hashimoto : Evaluation de la Prévalence et des Facteurs Associés.

N. KHODJA1. ,A.KHODJA 2,I.LAIDOUNI1, S.BENSALEM 2.,K.

1-Laboratoire centrale ,Unité de biochimie HMRUconstantine Algerie
2-Service de medicine interne ,Unité endocrinologie HMRUConstantine
Algerie

INTRODUCTION

La thyroïdite d'Hashimoto est la maladie auto-immune la plus fréquente. Des études suggèrent une association entre la vitamine D et l'incidence des maladies auto-immunes, y compris la thyroïdite d'Hashimoto (TH).

L'objectif de notre travail était d'évaluer le statut vitaminique D des sujets ayant une thyroïdite de Hashimoto (TH) et identifier les facteurs associés à une hypovitaminose D.

Materiels et Methodes

Il s'agit d'une étude transversale rétrospective menée chez 45 patients atteints d'une TH à l'hôpital militaire de Constantine sur une durée de 2mois(mars-avril 2026).

➤ Un dosage concomitant de la FT4, TSH, Vitamine D ont été effectuer sur l'Automate Cobas e 411 (Roche)

➤ Valeurs usuelles de la 25-hydroxyvitamine D :

- Normal : $V \geq 30$ ng/ml
- Insuffisance : $20 \leq V \leq 30$ ng/ml
- Déficit : $10 \leq V \leq 20$ ng/ml
- Carence : $V < 10$ ng/ml.

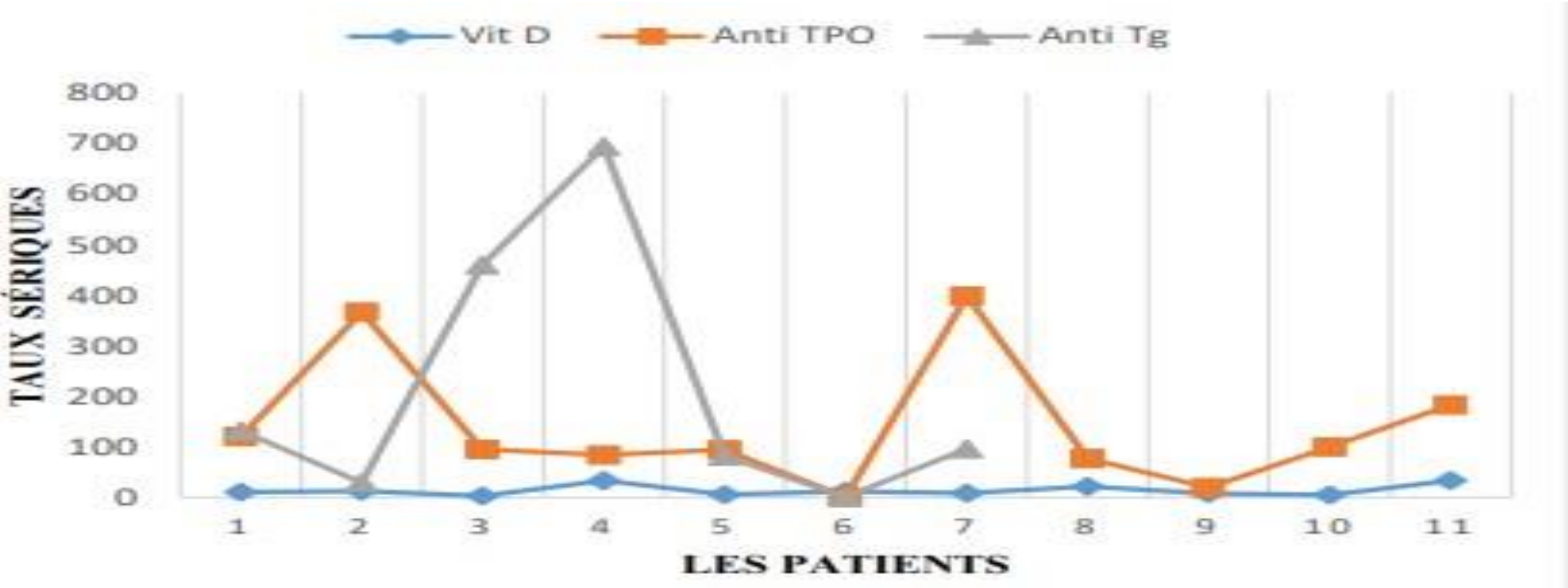


Figure 7 : La comparaison des taux des autoanticorps anti-TPO et anti-Tg avec le taux de la vitamine D mesuré

DISCUSSION

- ❑ Dans notre etude nous avons remarque une predominance feminine ce qui Concorde avec les études de Gleicher et Barad (2007); Ngo et al., (2014) ; Boufaïda et al., (2017). Elle peut être expliquée par la différence des réponses immunitaires, dont les femmes présentent une augmentation de l'incidence et/ou de la sévérité des maladies auto-immunes par rapport aux hommes Guéry (2010).
- ❑ Les tranches d'âge les plus touchées par la pathologie sont celles de [34-38] et [44-48] dont elles représentent 17,77%. Nos résultats rejoignent ceux des études antérieures dont celles de Boufaïda et al., (2017) ; Abdesselem et al., (2018) ; Guanqun (2020). Il a été rapporté que le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge dans les études de Agarwal et Busse (2010) ; Shaw et al., (2010). Cet affaiblissement concerne les réponses contre les agents étrangers et s'accompagne avec une perte de tolérance contre les antigènes du soi Gruver et al., (2007) ; Duggal et al., (2013).
- ❑ L'atteinte des patients par le DNID précède leur atteinte par l'HT. Ces résultats concordent avec ceux de Al-Geffari et al., (2013). Une présence d'autoanticorps antiTPO et anti-Tg a été observée chez des patients atteints de DNID (22 % et 3,5 % respectivement) Kochkar, (2008). Dans l'étude de Parlițeanu et Cheța, (2021), l'atteinte par 62% 16% 7% 4% 2% 9% Non associé Diabète de type 2 Hypertension artérielle Cardiopathies Anémie Autres 42 l'HT était significativement plus élevée dans une population atteinte de DNID composée de 5064 patients.
- ❑ L'association de l'hypertension artérielle à l'HT peut être expliquée par l'influence de la baisse du taux des hormones thyroïdiennes dont ces dernières jouent un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. les études de Kotsis et al., (2007) ; Cai et al., (2011) ont démontré que l'hypertension artérielle est fréquente lors des hypothyroïdies.
- ❑ D'autre part des études ont démontré que l'HT peut être un facteur de risque au développement des pathologies susmentionnées sauf l'allergie Singh et al., (2008) ; Ochs et al., (2008) ; Bouabdellaoui et al., (2018) ; Braunstein, (2020) ; Jerome (2020) ; Romdhane et al., (2020) ; Khamal Doghri, (2020).
- ❑ Les résultats montrent un statut vitaminique variable entre les différents stades de l'HT. Le déficit en vitamine D était observé chez des patients avec un statut hypothyroïdien. Dans le stade d'euthyroïdie, les patients avaient une carence en vitamine D, alors que dans le stade de l'hypothyroïdie infraclinique, ils avaient une insuffisance en vitamine D. Ceci reflète une variation dans le degré de l'hypovitaminose D durant les différents stades d'HT. Ces résultats sont en accord avec ceux de Bozkurt et al., (2013) ; Mansournia et al., (2014) ; Ke et al., (2017) qui ont démontré une corrélation entre la sévérité de l'hypovitaminose D et le degré de l'HT avec une diminution du volume de la glande. Cependant, d'autres études n'ont pas trouvé de différences significatives comme celles de Tamer et al., (2011) ; Unal et al., (2014).
- ❑ Dans notre étude le taux des autoanticorps est élevé par rapport au taux de la 25(OH)D de chaque patient. Ces résultats sont en accord avec ceux de Kivity et al., (2011) ; Tamer et al., (2011) ; Bozkurt et al., (2013) ; Shin et al., (2014) ; Muscogiuri et al., (2016).
- ❑ En outre, une présence d'une dysfonction thyroïdienne a été notée ,ces résultats peuvent être expliqués par la diminution de la concentration de la vitamine D dans la pathogénicité d'HT.
- ❑ Tandis que d'autres études n'ont observé aucune corrélation telle que celle de Mansournia et al., (2014) ou au contraire, une corrélation positive a été rapporté chez le groupe des hommes dans l'étude de Yasmeh et al., (2016).
- ❑ D'autres études de Mazokopakis et al., (2007) ; Dizdar et al., (2016) ont démontré que la supplémentation en vitamine D dans les doses thérapeutiques est associée à une réduction significative des titres d'anticorps anti-TPO chez les patients atteints d'HT.

RESULTATS

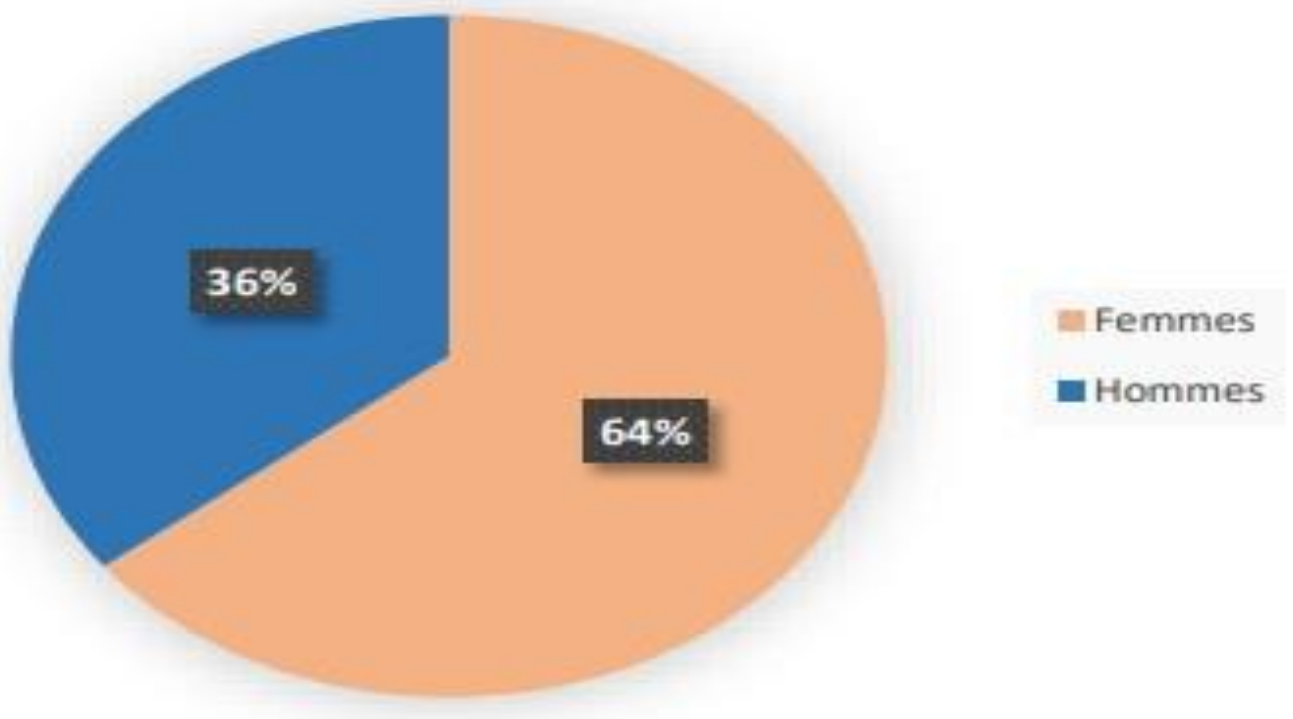


Figure 1:répartition des patients selon le sexe

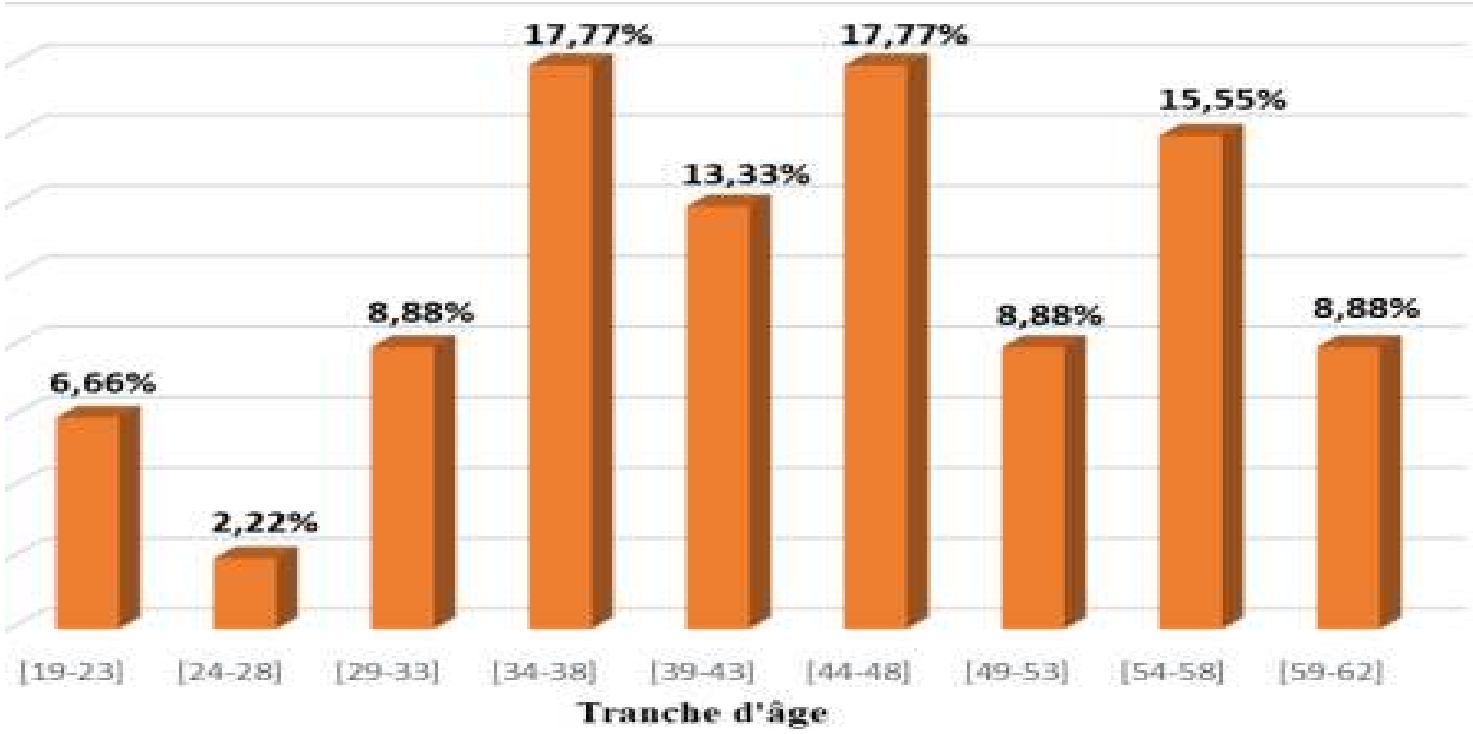


Figure 2 : Répartition des patients selon les tranches d'âge.

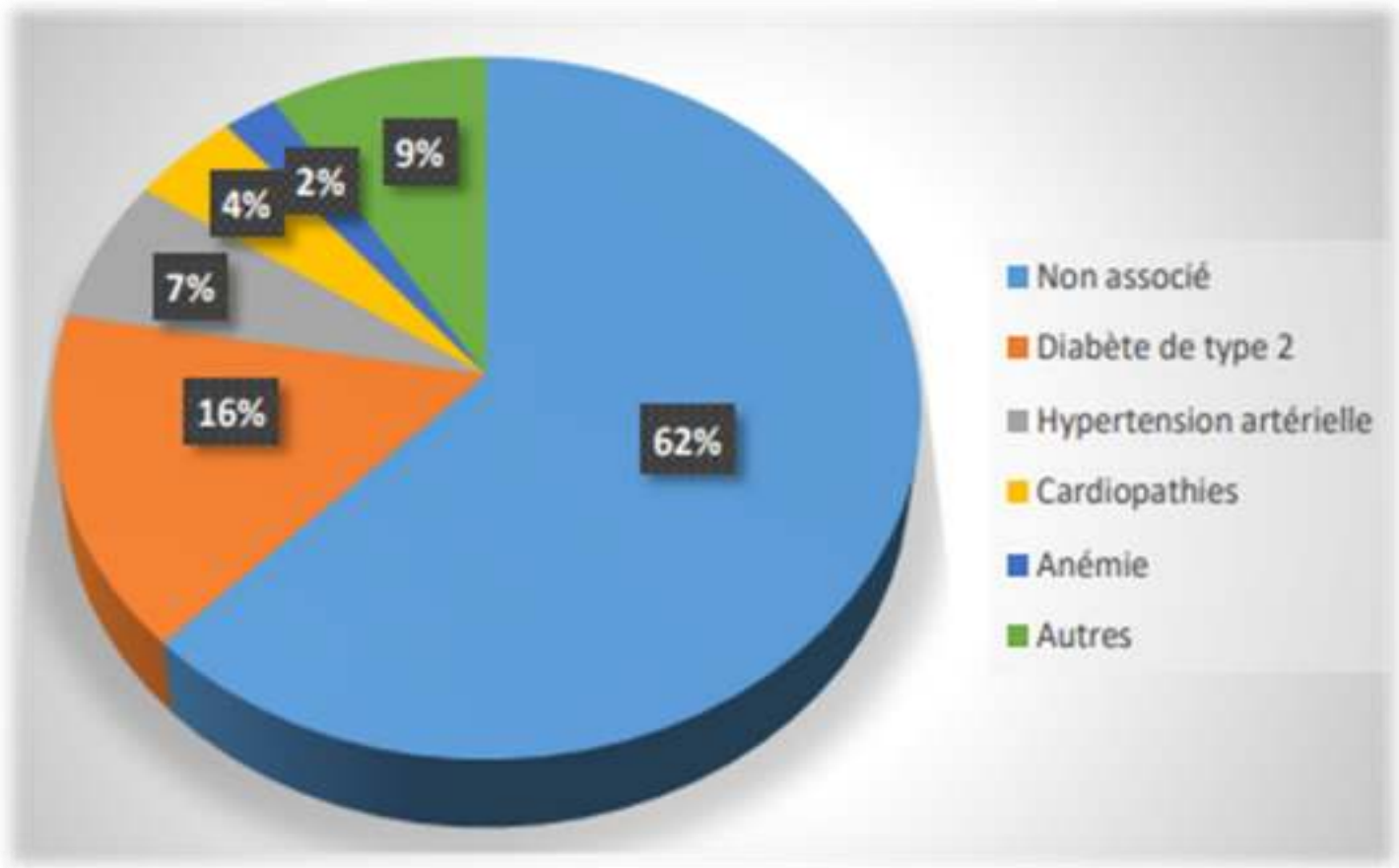


Figure 3 : Répartition des cas selon les maladies associées au statut pathologique des patients.

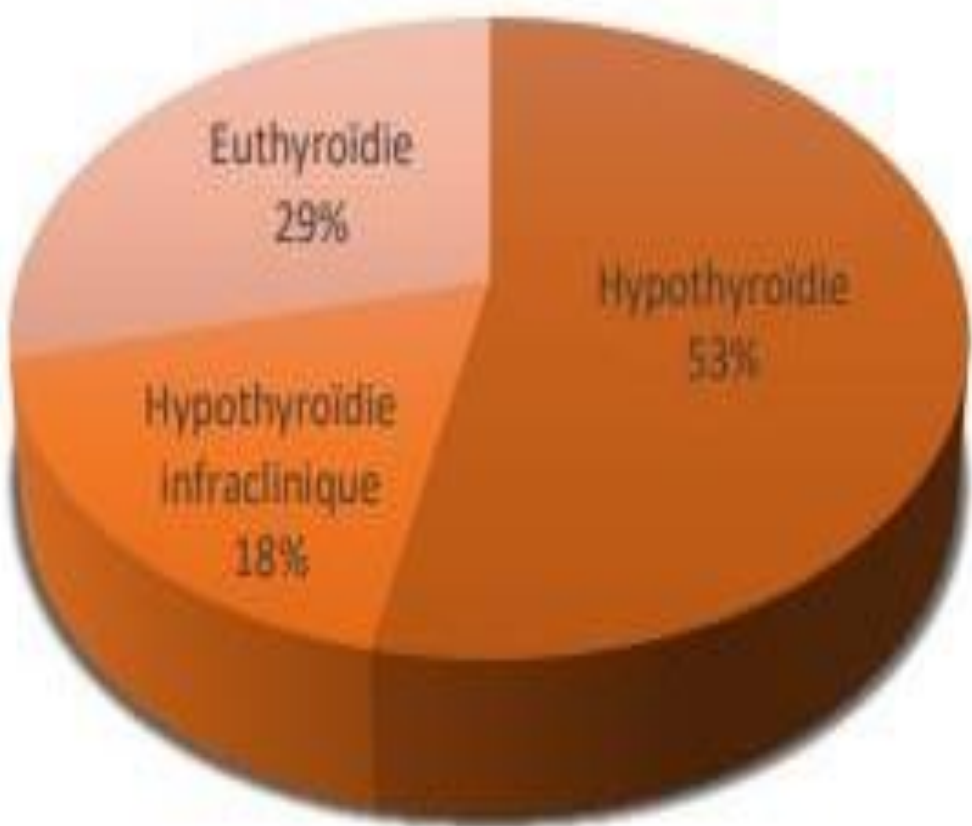


Figure 4 : Les différents stades de l'HT chez les patients.

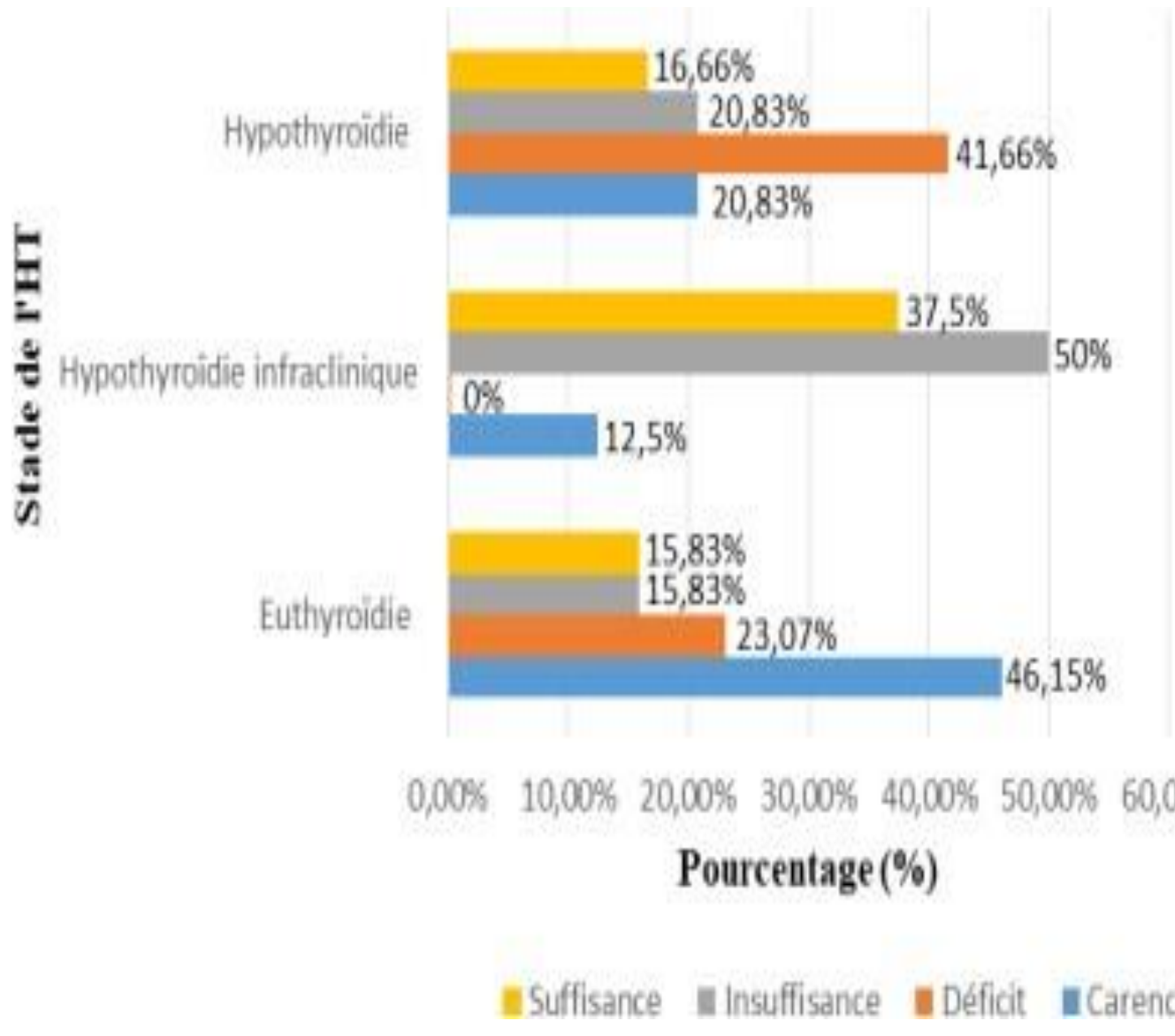


Figure 5 : Le statut de la vitamine D selon les différents stades d'HT.

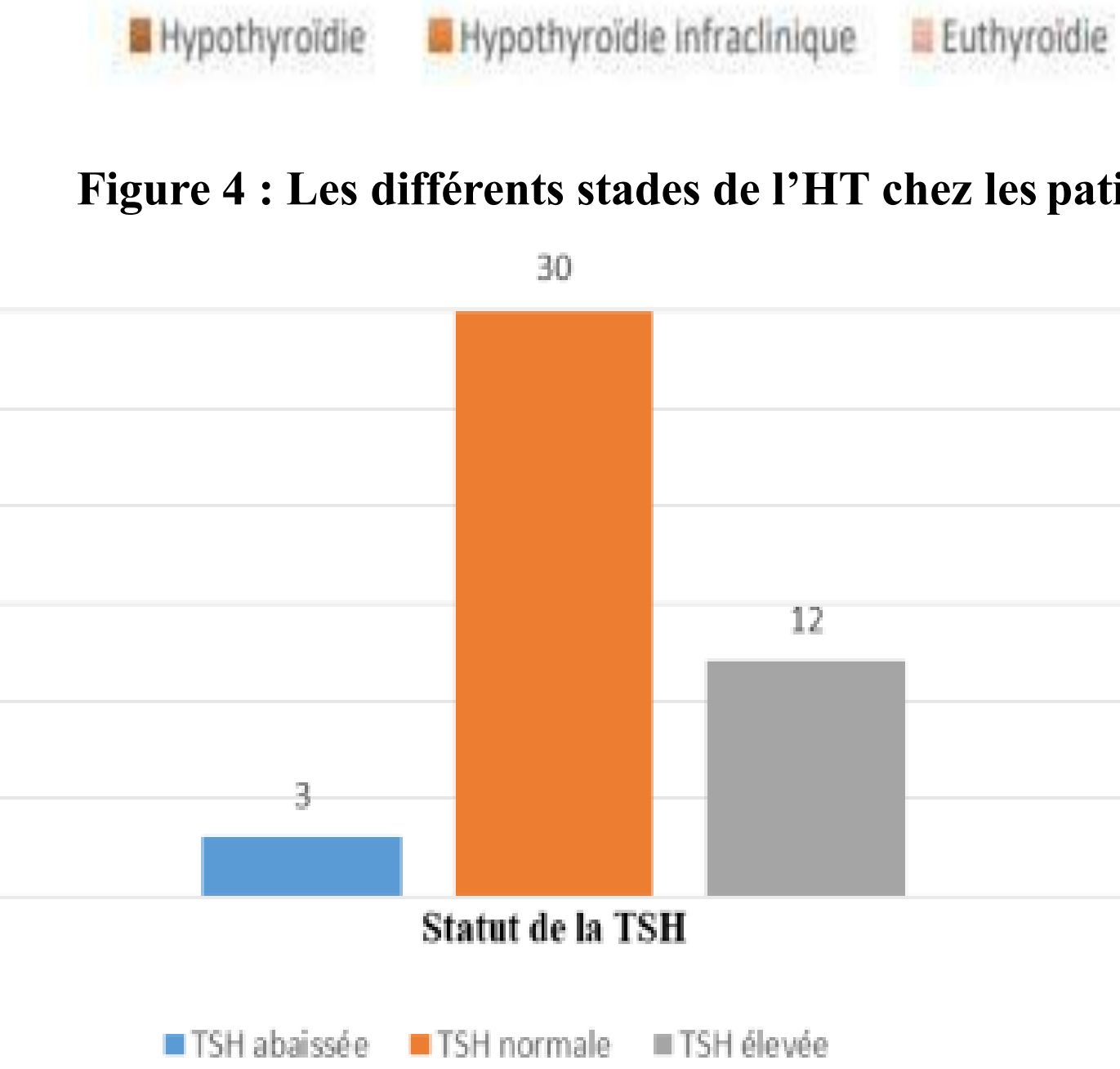


Figure 6 : Le statut de la TSH présenté chez les patients d'HT

CONCLUSION

- À travers cette étude approfondie sur la carence en vitamine D chez les patients atteints de thyroïdite d'Hashimoto, nous avons pu mettre en lumière l'importance de cette relation complexe.
- Les résultats révèlent une prévalence significative de carence en vitamine D au sein de cette population, soulignant la nécessité d'une surveillance adéquate et d'une supplémentation éventuelle pour optimiser la gestion de la thyroïdite d'Hashimoto.
 - L'identification des facteurs associés à cette carence apporte un éclairage précieux sur les influences multifactorielles de la maladie.
- Ces découvertes fournissent des pistes pour des approches de traitement plus holistiques et ciblées, visant à améliorer la qualité de vie des patients et à optimiser leur état de santé général.
- Cette étude encourage également des investigations plus poussées pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et les implications cliniques de cette interaction entre la carence en vitamine D et la thyroïdite d'Hashimoto

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1- Abdesselem H., Jemal M., Kandara H., Kammoun I. et Ben Salem L. (2018). Thyroïdite de Hashimoto : évaluation des connaissances d'un groupe de patientes sur leur maladie Annales d' Endocrinologie.
2- Amiri S. (2020). La carence en vitamine D touche une grande partie de la population. Mais que sait-on de son lien avec les troubles de la thyroïde ? Nutrients
3- Boufaïda N., Marhari H., El Ouahabi H. (2017). Thyroïdite d'Hashimoto : à propos de 106 cas. Annales d'Endocrinologie.
4- Bozkurt N.C. Karber B. Ucan B. Sahin M. Cakal E. Ozbek M. Delibasi T. (2013). The association between severity of vitamin D deficiency and Hashimoto's thyroiditis. Endocr
5- Cai G., Ren Y. et Shi, J. (2011). Blood pressure levels in patients with subclinical thyroid dysfunction: a meta-analysis of cross-sectional data. Hypertension Research
6- Chao G., Zhu Y., et Fang L. (2020). Correlation Between Hashimoto's Thyroiditis-Related Thyroid Hormone Levels and 25-Hydroxyvitamin D. Frontiers in Endocrinology, 11. Department of General Practice, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University, Hangzhou, China.
7- Choi Y.M., Kim W.G., Kim T.Y., Bae S.J., Kim H.K., Jang E.K. Jeon M.J., Han J.M., Lee S.H., Baek J.H., Shong Y.K. et Kim W.B. (2014). Low levels of serum vitamin D3 are associated with autoimmune thyroid disease in pre-menopausal women
8- D'Aurizio F., Villalta D., Metus P., Doretto P., Tozzoli R. (2015). Is vitamin D a player or not in the pathophysiology of autoimmune thyroid diseases? Autoimmun. Rev
9- Dizdar O., Simsek Y., Cakir I., Yetmis M., Baspinar O., et Gokay F. (2016). Effects of Vitamin D treatment on thyroid autoimmunity. Journal of Research in Medical Sciences
10- Dohee K. (2017). The Role of Vitamin D in Thyroid Diseases. International Journal of Molecular Sciences.
11- Garber J.R., Cobin R.H., Gharib H., Hennessey J.V., Klein I., Mechanick J.I., et al. (2012) Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association
12- Goswami R., Marwaha R.K., Gupta N., Tandon N., Vishnubhatla S., Tomar N., Ray D., Kanwar R. et Agarwal R. (2009). Prevalence of vitamin D deficiency and its relationship with thyroid autoimmunity in Asian Indians : a community based survey. British Journal of Nutrition